REIN · SURRÉNALE · RS-02

# Incidentalome surrénalien

**ESE/ENSAT 2023**
scanner sans injection, wash-out, IRM, suivi

**Définition :** masse surrénalienne découverte sur une imagerie non réalisée pour une pathologie surrénalienne. Deux questions systématiques : **bénin ou malin ?** et **sécrétant ou non ?** (bilan hormonal pour tous : test de freinage à la dexaméthasone 1 mg ; métanéphrines si non clairement bénin à l'imagerie ; aldostérone/rénine si HTA ou hypokaliémie).

## ALGORITHME D'IMAGERIE ESE/ENSAT 2023

**Scanner sans injection** en 1re intention

›

**Homogène et ≤ 10 UH**
**Adénome riche en lipides : bénin**, aucune imagerie supplémentaire quelle que soit la taille (≈ 70 % des cas)

›

**Homogène, 11–20 UH, < 4 cm**
Imagerie complémentaire immédiate (wash-out, IRM) ou scanner sans injection à 12 mois

›

**> 20 UH ou hétérogène, ou ≥ 4 cm et hétérogène**
Discussion en **RCP** ; chirurgie le plus souvent

Seuil de 10 UH : sensibilité 100 %, spécificité 58 % · seuil de 20 UH : sensibilité 97 %, spécificité 77 %. Le seuil de taille de 4 cm de 2016 n'est plus un critère isolé.

## EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

### Scanner avec wash-out

- Sans injection, portal (60–70 s), tardif (15 min)
- **Wash-out absolu** = (portal − tardif) / (portal − sans injection) ; ≥ 60 % : adénome
- **Wash-out relatif** = (portal − tardif) / portal ; ≥ 40 % : adénome
- Moins fiable que la densité spontanée (phéochromocytomes et métastases peuvent laver)

### IRM

- **Chute de signal en opposition de phase** (graisse intracellulaire) : adénome
- Utile si 10–30 UH, chez l'enfant, la femme enceinte
- Phéochromocytome : T2 souvent intense, mais non spécifique

### TEP-TDM au FDG

- Masse indéterminée, contexte oncologique
- Fixation < foie : en faveur de la bénignité

BIOPSIE

Seulement si elle change la prise en charge (cancer extra-surrénalien connu) et **après exclusion d'un phéochromocytome**

## LÉSIONS À RECONNAÎTRE

| LÉSION | ARGUMENTS D'IMAGERIE |
|---|---|
| **Myélolipome** | Graisse macroscopique (< −30 UH) : bénin, aucun suivi |
| **Kyste, hématome** | Pas de rehaussement ; hématome : densité spontanée élevée, régression au contrôle |
| **Phéochromocytome** | > 10 UH, rehaussement intense, parfois kystique ou hémorragique ; métanéphrines indispensables |
| **Corticosurrénalome** | Grande taille, hétérogène, nécrose, calcifications, envahissement de la veine cave inférieure |
| **Métastase** | Contexte de cancer, bilatérale, croissance, hétérogène |

## SUIVI D'UNE MASSE INDÉTERMINÉE NON OPÉRÉE

**Contrôle**
scanner sans injection ou IRM à **6–12 mois**

**Croissance significative**
> 20 % et ≥ 5 mm du plus grand diamètre : chirurgie proposée

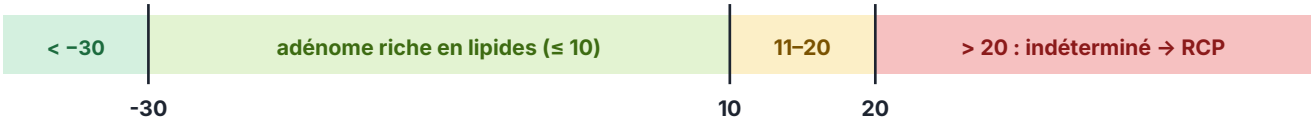
**Croissance infra-seuil**
nouveau contrôle à 6–12 mois

# Incidentalome surrénalien (suite)



## ATLAS VISUEL

### Densité au scanner sans injection (UH)




graisse : myélolipome

homogène < 4 cm : contrôle

IRM : chute de signal en opposition de phase = graisse intracellulaire (adénome)

Schémas simplifiés, non à l'échelle

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**Adénome surrénalien**
Radiopaedia · densité, wash-out
radiopaedia.org/articles/adrenal-adenoma

**Déplacement chimique (cas)**
Radiopaedia · opposition de phase
radiopaedia.org/cases/adrenal-adenoma-chemical-s

**Wash-out surrénalien**
Radiopaedia · calcul absolu et relatif
radiopaedia.org/articles/adrenal-washout

**Myélolipome surrénalien**
Radiopaedia · graisse macroscopique
radiopaedia.org/articles/adrenal-myelolipoma

**Protocole scanner surrénales**
Radiopaedia · phases
radiopaedia.org/articles/ct-adrenals-protocol

**Sources :** ESE 2023 adrenal incidentaloma guideline (ECE 2023) – www.ese-hormones.org/media/jjwm0ip2/adrenal-incidentaloma-gu... · Recent updates adrenal incidentalomas (PMC) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10475962/